

PERICARDIOCENTESIS

Julio Tito Camino Acha, Gregorio Enrique Fernandez Fernandez, Antonio Alfonso Fierro San Millan

INTRODUCCIÓN

Solo debe realizarse en casos de emergencia. Se realiza con una aguja o con una cánula con control electrocardiográfico o ecocardiográfico con la finalidad de evacuar material líquido de cavidad pericárdica con fines diagnósticos o terapéuticos.

INDICACIONES.

- Taponamiento cardíaco
- Derrame pericárdico con repercusión clínica y hemodinámica.
- Pericarditis purulenta o derrame pericárdico crónico.

CONTRAINDICACIONES

Si es un procedimiento programado, No realizar sin exámenes de laboratorio: Hemograma, coagulación (alteración grave de la coagulación).

Si es un procedimiento de emergencia, La única contraindicación absoluta sería la no indicación de maniobras de reanimación, bien por enfermedad terminal o por situación irreversible.

Diversas técnicas de pericardiocentesis dependiendo de la urgencia, de la experiencia del profesional médico y de la demanda tecnológica del centro hospitalario donde se realiza el procedimiento.

- Pericardiocentesis en la cabecera del paciente con la simple monitorización ECG y sin monitorización hemodinámica. Sin control radiológico o ecocardiográfico, depende de experiencia del médico. Solo debe de realizarse en casos de emergencia. Se realiza con una aguja o con una cánula.
- Pericardiocentesis con control electrocardiográfico y ecocardiográfico. Permite elegir el lugar de la punción: transxifoidea, subcostal, transtorácica, etc. Según distribución del derrame pericárdico. Permite la inserción de catéteres intrapericárdicos
- Pericardiocentesis con control radiológico y hemodinámico, se realiza en: unidad de coronaria, cuidados intensivos o en unidad de hemodinámica. Si se agrega control ecocardiográfico permite ver cantidad de líquido y su distribución, es la más segura, permite controles hemodinámicos y pericardiocentesis exhaustivas.

PROCEDIMIENTO

La vía de abordaje más usada es la subxifoidea: a nivel de la punta del apéndice xifoides a 2 cm a la izquierda sobre el margen paraesternal izquierdo.

- Monitorización continua: ECG, FR. SaTO₂ y TA.
- Atropina 1mg IV, para evitar reacciones vágales.
- Asepsia y antisepsia de la zona subxifoidea
- Se conecta la jeringa de 20 ml con una llave de tres vías a un catéter de 16 - 18 G.
- Posición: Paciente en decúbito supino, posición elevada, si la situación lo permite (unos 30°) para desplazar anteriormente el líquido pericárdico.
- Anestesia local: lidocaína 5 ml al 1 % en el trayecto de punción subxifoidea.

- Punción: introduciendo la aguja formando un ángulo de 45° con la piel y dirigiéndola hacia el hombro/escapula izquierda.
- Se avanza muy lentamente con la aguja aspirando constantemente y retirando periódicamente el mandril hasta notar una resistencia(saco pericárdico). Al traspasar el pericardio se tiene la sensación de haber atravesado una membrana, momento en que se detiene el avance de la aguja y se aspira. Si se observa en la monitorización electrocardiográfica extrasístoles ventriculares, alteraciones del QRS o elevación del ST se debe retirar lentamente la aguja hasta que desaparezcan las alteraciones, se produce porque la aguja entra en contacto con el epicardio.
- Se introduce una guía por la aguja, se retira la aguja y se pasa por la guía un dilatador, se retira este y se pasa un catéter por la guía, se retira la guía y se fija. Luego se conecta el catéter a aspiración continua.

COMPLICACIONES

- Punción de vasos arteriales: arterias coronarias, intercostales o mamarias.
- Punción o laceración de cavidades cardíacas.
- Neumotórax.
- Arritmias ventriculares como fibrilación ventricular.
- Parada cardíaca.
- Punción de esófago.
- Punción de Peritoneo.

BIBLIOGRAFÍA

- Revista Española de Cardiología. 2000;53:394-412 - Vol. 53 Núm.3. Guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología en patología pericárdica: <http://www.revespcardiolog.org/es/guias-practica-clinica-sociedad-espanola/articulo/9345/>
- Pericardiocentesis: técnica y seguridad en el procedimiento. Drs. Kaduo Arai H.1 MASVC, Ricardo Tovar2 MASVMC
- Guía de actuación en Urgencias 5ª edición. M.J. Vázquez Lima. J.R. Casal Codesido. Editorial Médica Panamericana.
- Tratado de Medicina de Urgencias. M.S. Moya Mir, P. Piñera Salmerón, M. Mariné Blanco. 1ª Edición. 2011.
- ATLS. Soporte vital avanzado en trauma. Manuel del curso para estudiantes. Colegio Americano de Cirujanos Comité de Trauma. Novena Edición 2012. Pág. 67, 102, 120, 121.